

Locomotion 1

partie A

Anamnèse et cadre de l'examen clinique du système ostéo-articulaire

Dr Stéphane Genevay
Médecin adjoint, rhumatologie
Mai 2020

Introduction

Système locomoteur

Système locomoteur /ostéo-articulaire concerne 3 spécialités

(avec des frontières floues qui varient selon les pays et les habitudes) :

- **Orthopédie** : chirurgie et traumatologie de l'appareil locomoteur
- **Médecine physique et rééducation** : lutte contre le handicap après maladie ou chirurgie en coordonnant plusieurs professions médicales et paramédicales (ex : polytrauma, amputés, brûlés, maladies neuromusculaires)
- **Rhumatologie** : maladies du système locomoteur et maladies systémiques/immunologiques.

Introduction

Système locomoteur

Importance de l'anamnèse & de l'examen clinique

Le diagnostic :

- Permet de définir la localisation, l'extension et d'établir un diagnostic différentiel.
- Les examens complémentaires (prise de sang, imagerie) sont rarement pathognomoniques (ils sont fréquemment « non-spécifique »).
- Les examens complémentaires **DOIVENT TOUJOURS** être interprétés dans le contexte d'une bonne anamnèse & examen clinique.

Le suivi :

- Anamnèse & examen clinique sont également les piliers lors du suivi.

Introduction

Système locomoteur

Difficultés de l'anamnèse & de l'examen clinique

- Focus de chaque spécialité est différent
- Nombreux tests pour chaque région
- Nombreux tests pour chaque structure
- Nombreuses variantes de chaque test
- Validité et performance de chaque test variable

Introduction

Système locomoteur

Synthèse :

- Ce cours en 4 leçons est le fruit d'un accord entre les 3 spécialités des 5 universités
- Un examen clinique du système locomoteur ne doit en aucun cas être pratiqué à travers un vêtement.
- Importance de pratiquer +++++
→ **Aucune démonstration ou vidéo ne peut remplacer la pratique !**

Introduction

Système locomoteur

4 cours de 2h, le 1^{er} à 2 phases distinctes :

- 1. Introduction à l'anamnèse et à l'examen clinique**
 - a) **les bases théoriques** (objet de la suite de cette présentation)
 - b) **2 jeux de rôle pour illustrer l'anamnèse**
2. Examen clinique des membres inférieurs
3. Examen clinique des membres supérieurs
4. Examen clinique de la colonne vertébrale (rachis)
et introduction au concept de douleur généralisée

Préambule session 1

Structures & pathologies (définitions)

Arthrite / arthralgie

- Mono / Oligo (ou pauci) / poly ... articulaire

Abarticulaire (= extra = para...articulaire)

- Muscles : déchirure, hématome, myalgie, myosite, amyotrophie
- Tendons : tendinopathie, ténosynovite, rupture tendineuse
- Bourses : bursite
- Enthèse : enthésite
- Périoste : périostite
- Os : déformation, fracture, tumeur, ostéophyte

Anamnèse : généralité

L'anamnèse dirigée

- Oriente l'examen clinique
- Apprécie l'intensité de la maladie
- Informe de l'intensité de la souffrance

Plaintes principales

- Douleur = plus fréquent
- Gêne fonctionnelle

Points déterminants

- Caractère et localisation des symptômes
- Répercussion fonctionnelle (handicap)
- Présence de symptômes généraux accompagnants
- Facteurs psychosociaux (= facteurs de risque de chronicité)
- Anamnèse familiale / habitudes de vie

Anamnèse

1.- Caractère et localisation des symptômes

A. Où ? Région, localisation

- a) Région du corps (une ou multiple, à pointer avec un doigt ainsi que le trajet)
- b) Localisée (si articulaire : mono, oligo (= pauci, 2-3) ou poly), diffuse
- c) Structure (articulation ou tissus mous)

B. Quand ?

- a) Durée : aiguë < 3 mois, chronique > 3 mois
- b) Rythme quotidien (nuit, matin, vespéral : douleur mécanique vs. Inflammatoire)
- c) Au repos, au démarrage, au mouvement, avec la fatigue

C. Comment ? a) type de douleur

- a) Caractéristiques (crampes, sourdes, lancées/décharges, brûlures, fourmillements, ...)
- b) Intensité Légère, moyenne, forte ou EVA (ou ENA : échelle numérique analogique)
- c) Conséquences sur activités (soins personnels, vie sociale et professionnelle)

D. Comment ? b) évolution

- a) Début : brutal ou progressif
- b) Variations spontanées (permanent, récidivant)
- c) Variations induites (facteurs soulageant ou aggravant)
- d) Effet des traitement reçus

Anamnèse de la douleur

1.- Caractère suite

On caractérise plusieurs types de douleur (**inflammatoire, mécanique, viscérale, vasculaire, neuropathique, ...**).

Celles qui sont propres au système O-A sont de 2 types :

Mécanique

- Soulagée par le repos
- Aggravée par l'activité
- Réveille peu la nuit et lors des mouvements
- Peu de raideur matinale (<15')

Inflammatoire

- Augmentée lors du repos
- Améliorée par l'activité physique
- Provoque un réveil, même sans mouvement, en 2^{ème} partie de nuit
- Longue raideur matinale (> 60')

Anamnèse

2.- Complémentaire

Anamnèse par système

- Autres symptômes très utiles pour les rhumatismes inflammatoires qui peuvent affecter conjointement les autres systèmes

Facteurs psycho-sociaux (=principaux facteurs de chronicité)

- Kinésiophobie : peur du mouvement
- Catastrophisme : voir « tout en noir »
- Anxiété
- Perte de plaisir
- Difficultés /stress professionnel

Anamnèse familiale / habitudes de vie

- Module la probabilité de certaines maladies

Examen clinique

Généralité

1. Se pratique sur un(e) patient(e) en sous-vêtements
2. S'entraîne sur un(e) collègue avec la région à examiner suffisamment dénudée mais en respectant la pudeur de chacun.
3. Chaque fois que cela est possible le côté sain sert de référence pour la normalité (amplitude, douleur, etc.)
4. Il est important d'adopter un déroulement logique pour chaque articulation, à l'image de ce qui est proposé ci-après.

Examen clinique

Généralité

Propre au système locomoteur :

- Inspection
- Palpation
- Examen fonctionnel

En pratique clinique toujours complété au moins par :

- ***Neurologique succinct*** : dans la région considérée, le plus souvent force, sensibilité tactile superficielle et réflexes explorant les racines C5-C8 et L3-S1
- ***Vasculaire*** : palpation des pouls (dans la région considérée)

(qui, ici seront enseignés et contrôlés dans les unités correspondantes et donc pas demandés à l'ECOS locomoteur de 3ème)

Examen clinique

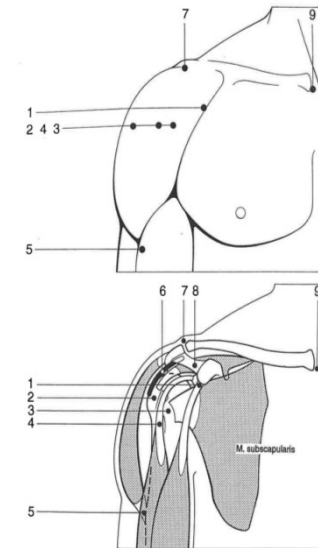
1. Inspection

- **Couleur** (érythème, hématome, ...)
- **Trophicité** (amyotrophie, aspect de la peau)
- **Tuméfaction** (épanchement, ostéophyte, bursite, ...)
- **Déformation** (osseuse, articulaire)
- **L'observation du mouvement naturel** (marche, s'assied, se déshabille) est « à cheval » entre l'inspection et l'examen fonctionnel.
 - Défaut d'axe; Boiterie; perte de fluidité ou limitation du mouvement peuvent être repérées dès le début.
- **Les mensurations** (poids, taille)

Examen clinique

2. Palpation

- Repères anatomiques (cf. pdf examen clinique, « schémas blancs » = repères cutanés des structures à connaître)
- Chaleur (= inflammation)
- Présence de douleur
 - Localisation/structure
 - Intensité
 - Reproduction de LA plainte du patient ?
- Tuméfaction dure ou molle (ostéophytes, épanchement, œdème, ...)
- Crépitations (nécessite la mobilisation de la structure sous-jacente, articulation (arthrose) ou tendon (tenosynovite))

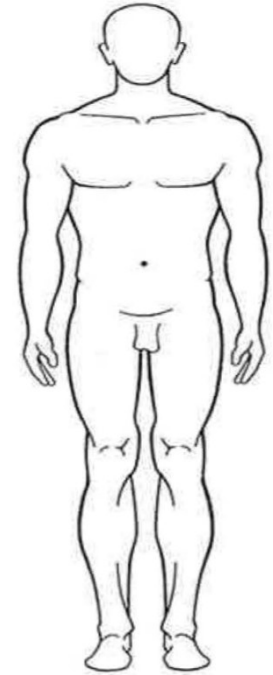


Examen clinique

3. Examen fonctionnel

Schéma général, adaptable selon certaines articulations / régions

1. **Amplitude du mouvement en actif (le patient fait le geste) :**
le patient fait le mouvement sur demande
Connaître la normalité (position neutre, amplitude théorique)
Comparer au côté normal
Savoir utiliser un goniomètre et la notation d'angle
Flexion/extension : $90^{\circ}/0^{\circ}/90^{\circ}$
Y a-t-il une reproduction de LA douleur du patient ?
2. **Amplitude du mouvement en passif (le thérapeute fait bouger) :**
Uniquement lorsque l'actif est limité
L'examineur termine le mouvement en essayant d'arriver à une amplitude normale



Actif = passif $\rightarrow$ problème *a priori* articulaire
Actif <<< passif $\rightarrow$ problème *a priori* abarticulaire

Examen clinique

3. Examen fonctionnel suite

3. Test de la force

- Contre résistance, comparer au côté sain
- Dans toutes les directions de mouvement (Flex/ext/Rot int /...)
- Cotation comme en neurologie M5 à M0
- Similaire mais pas identique à l'examen neurologique qui lui va tester en fonction d'une racine (ex : extenseur propre du gros orteil pour L5) ou d'un nerf (ex : extension du poignet pour le n. radial).

4. Tests spécifiques

- Nombres très variables selon les articulations
- En général servent à préciser l'origine des symptômes
 - une structure (ex : tendon, ménisque,...)
 - un phénomène pathologique (ex : instabilité, hyperlaxité,...)

Compléments :

La mesure de la mobilité

La position neutre (= angles articulaires à 0°) :

= debout, pied écart naturel, bras le long du corps, paume tournée vers la cuisse

- Un poignet avec 60° de flexion et 80° d'extension est noté :

flexion/extension : 60°/0°/80°

- Un genou avec une flexion normale (140°) et aucun degré d'extension est noté :

flexion/extension : 140°/0°/0°

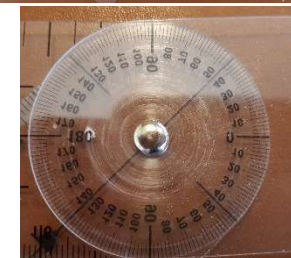
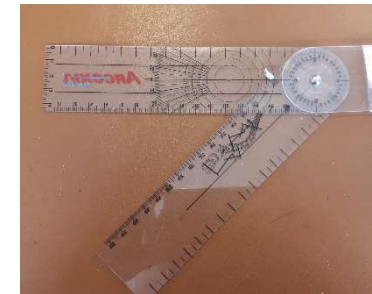
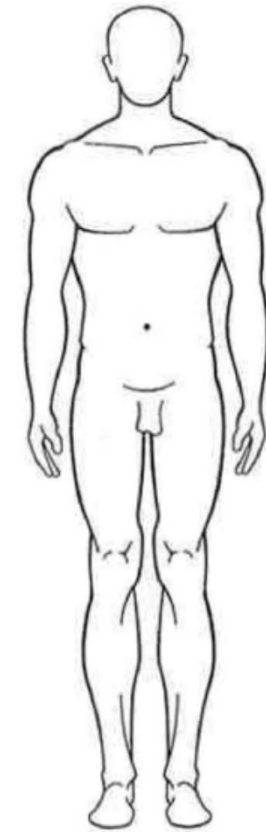
- Un coude qui se fléchit normalement (130°) mais qu'il n'est pas possible d'étendre complètement (=flexum de 20°) est noté :

flexion/extension : 130°/20°/0°

signifiant par là que le 0 n'a pas pu être atteint par l'articulation.

L'utilisation d'un goniomètre permet de prendre ses repères et d'être plus précis lorsque cela est nécessaire.

Avec de l'entraînement, peut se mesurer « à l'œil ».



Compléments :

Hypermobilité / hyperlaxité

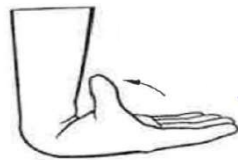
- Peut ne concerner qu'un nombre limité d'articulations (fréquemment épaules, chevilles)
- Il existe un état d'hypermobilité généralisée qui peut être associé à certaines maladies du collagène (ex : syndrome d'Ehlers Danlos)
 - Score de Beighton 9 articulations testées
 - **hypermobilité généralisée si ≥ 6 articulations hypermobiles**



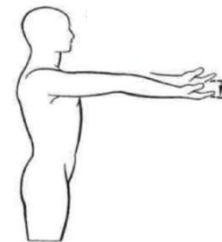
Extension du genou $>10^\circ$, x 2 côtés



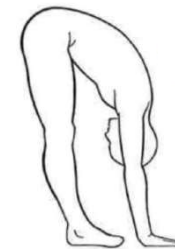
Extension du 5^{ème} doigt
à $> 90^\circ$
x 2 côtés



Flexion du pouce touche
l'avant-bras
x 2 côtés



Extension du
coude $> 10^\circ$
x 2 côtés



Flexion du tronc
jambes tendues :
paumes au sol

Compléments :

Force musculaire

Une faiblesse (sur amyotrophie) peut se voir dans de nombreuses conditions ostéo-articulaires

- Rupture tendineuse
- Arthropathie chronique (arthrite ou arthrose)

Peut être due à un problème neurologique

- Neuropathie ou radiculopathie par ex.

Le test de force peut être très perturbé par la douleur.

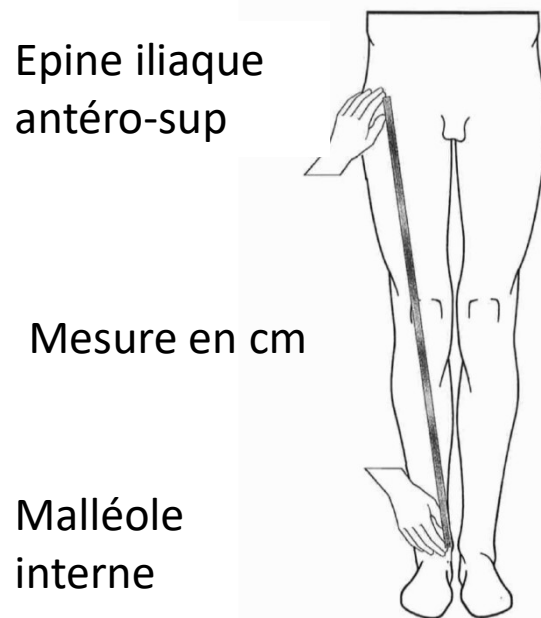
Cotation :

- **M0** = pas de contraction musculaire visible
- **M1** = contraction visible/palpable sans qu'il y ait de mouvement articulaire
- **M2** = mouvement possible seulement en l'absence de pesanteur
- **M3** = mouvement possible contre la pesanteur
- **M4** = mouvement possible contre une certaine force appliquée en plus de la pesanteur
- **M5** = force normale

Compléments :

Mesure de la longueur des membres inférieurs, mesures cliniques

1^{ère} méthode



2^{ème} méthode



Ajouter des planchettes d'épaisseur différente sous le membre le plus court, jusqu'à obtenir des crêtes iliaques horizontales

Attention mesures perturbées par ex. lors de flexum de genou ou de hanche ou scoliose

En général pas de répercussion clinique en dessous de 1 à 1.5 cm

Compléments :

Mesure de la longueur des membres inférieurs, mesures cliniques

1ère méthode

Epine iliaque antéro-sup

Mesure en cm

Malléole interne

Attention, différent du livre de référence



2ème méthode



Ajouter des planchettes d'épaisseur différente sous le membre le plus court, jusqu'à obtenir des crêtes iliaques horizontales

Attention mesures perturbées par ex. lors de flexum de genou ou de hanche ou scoliose

En général pas de répercussion clinique en dessous de 1 à 1.5 cm

2^{ème} partie de locomotion 1

- Poser des questions concernant cette 1^{ère} partie
- Entraînement à l'anamnèse à l'aide de 2 vignettes cliniques.